



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY KOMPREHENSIF)**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 951.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

Tentang
Pedoman Kerja Tim Ponek

Disusun oleh :
Ketua PONEK



(dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp. OG)

Di Setujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes., AFP., CCHt., CI., CHAE., CHQP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Tim PONEK Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja TIM PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2018. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja TIM PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep.)

KOMPREHENSIF (PONEK)

PENYUSUNAN

1. dr dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG
2. dr. Harli Noviar Kagendra., Sp.An
3. dr. Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed
4. dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A
5. dr. Fina Jazirah
6. Ninis Indrawati, S.Tr.Keb
7. Jihan Ananiah SSD, STr.Ke
8. Aulia Rahma, Amd.Keb
9. Debi Firmanasia, Amd. Kep

DAFTAR ISI

Judul.....	1
Halaman Pengersahan	2
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada	3
Kata Pengantar	6
Tim Penyusun	7
Daftar Isi	8
Daftar Tabel.....	9
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran.....	2
BAB II PENGORGANISASIAN	
2.1 Pimpinan dan Staf	3
2.2 Struktur PONEK	3
2.3 Uraian Tugas dan Wewenang	3
BAB III PROGRAM PONEK	
BAB IV MONEV DAN PELAPORAN	
4.1 Monitoring.....	21
4.2 Evaluasi.....	21
BAB V TATALAKSANA	
5.1 Pelayanan Rawat Jalan	22
5.2 Pelayanan Rawat Inap	22
5.3 Klasifikasi Penyulit.....	25
5.4 Penyelesaian dan Pengembalian Rekam Medis.....	25
5.5 Sisitem Rujukan	25
BAB VI PENUTUP	

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR : 951.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG

PEDOMAN KERJA TIM PONEK

(PELAYANAN OBSTERI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu di Rumah Sakit Prima Husada, serta pelaksanaan rumah sakit sayang ibu dan bayi, maka perlu adanya Pedoman Kerja Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
- Mengingat : a. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit;
- g. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- h. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
- i. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PONEK (PELAYANAN OBSTERI
NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Tujuan pedoman

- (1) Rumah Sakit wajib membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagai wadah koordinasi multidisiplin dalam penyelenggaraan pelayanan maternal dan neonatal emergensi secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan;
- (2) Tim PONEK dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan PONEK sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan kebijakan Rumah Sakit;
- (3) Tim PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit dan menjadi bagian dari organisasi pelayanan rumah sakit;
- (4) Tim PONEK bertujuan mendukung upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Neonatal melalui pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan;
- (5) Tim PONEK bertujuan mewujudkan pelayanan maternal dan neonatal yang berorientasi pada keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan tim multidisiplin yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan maternal dan neonatal emergensi secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Tim PONEK berada di bawah tanggung jawab Direktur Rumah Sakit dan berkoordinasi dengan seluruh unit pelayanan yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan maternal dan neonatal;
- (3) Tim PONEK wajib memiliki uraian tugas, tanggung jawab, dan

- wewenang yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit;
- (4) Direktur Rumah Sakit menetapkan Tim PONEK melalui Surat Keputusan Direktur;
 - (5) Pembentukan Tim PONEK bertujuan untuk:
 - a. Menjamin terselenggaranya pelayanan PONEK sesuai standar;
 - b. Meningkatkan koordinasi pelayanan maternal dan neonatal;
 - c. Mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - d. Menjamin kesinambungan pelayanan dan sistem rujukan maternal neonatal.
 - (6) Struktur organisasi Tim PONEK terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Sekretaris;
 - d. Dokter Spesialis anak;
 - e. Dokter Spesialis Anastesi;
 - f. Dokter Umum IGD;
 - g. Bidan ruang bersalin;
 - h. Perawat ruang Neonatus;
 - i. Bidan Poli klinik kebidanan;
 - j. Bidan IGD
 - k. Perawat ICU

BAB III

PROGRAM PONEK

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan menerapkan standart pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu;
- (2) Mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan ibu dan bayi;
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- (4) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetri dan neonatus termasuk pelayanan kegawatdaruratan (PONEK 24 jam);
- (5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif serta PMK pada BBLR;
- (6) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- (7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB 10 Langkah Menyusui dan peningkatan kesehatan ibu;
- (8) Melakukan pemantauan dan analisis :
 - a. Angka keterlambatan operasi SC;
 - b. Angka kematian ibu dan anak;
 - c. Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir.

BAB IV MONEV DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Tim PONEK wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan seluruh kegiatan pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif secara berkesinambungan sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- (2) Evaluasi pelayanan PONEK dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan melalui rapat evaluasi Tim PONEK yang dipimpin oleh Ketua Tim PONEK dan dihadiri oleh seluruh unsur profesi terkait;
- (3) Tim PONEK wajib melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap:
 - a. Kematian ibu;
 - b. Kematian neonatal;
 - c. Kasus maternal dan neonatal dengan komplikasi berat;
 - d. Kasus lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim PONEK atau Direktur Rumah Sakit.
- (4) Dokumen monitoring, evaluasi, audit, dan pelaporan PONEK wajib disimpan dan dikelola sesuai ketentuan manajemen dokumen rumah sakit serta dapat digunakan sebagai bahan akreditasi, pembinaan, dan supervisi eksternal;
- (5) Direktur Rumah Sakit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan PONEK untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan maternal dan neonatal yang optimal;

BAB V TATA LAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelayanan PONEK dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari secara terpadu, berkesinambungan, cepat, tepat, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi;
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan maternal dilaksanakan melalui:
 - a. Penanganan perdarahan obstetri;
 - b. Penanganan hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, dan eklamsia;
 - c. Penanganan infeksi maternal;
 - d. Penanganan persalinan dengan komplikasi;
 - e. Penanganan syok obstetri;
 - f. Penanganan kasus obstetri lain sesuai standar profesi dan SPO rumah sakit.
- (3) Pelayanan kegawatdaruratan neonatal dilaksanakan melalui:
 - a. Resusitasi neonatus;
 - b. Stabilisasi neonatus sakit dan risiko tinggi;

- c. Penanganan asfiksia neonatorum;
 - d. Penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR);
 - e. Penanganan sepsis dan infeksi neonatal;
 - f. Pelayanan perawatan intensif neonatal sesuai kemampuan rumah sakit.
- (4) Apabila diperlukan pelayanan rujukan, Tim PONEK wajib:
- a. Melakukan stabilisasi pasien sebelum dirujuk;
 - b. Menyiapkan dokumen rujukan secara lengkap;
 - c. Melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan;
 - d. Menjamin pendampingan tenaga kesehatan selama proses rujukan sesuai kondisi pasien.
- (5) Pelayanan transfusi darah bagi kasus maternal dan neonatal emergensi harus tersedia sesuai kebutuhan klinis melalui bank darah rumah sakit atau Unit Pengelola Darah yang bekerja sama dengan rumah sakit;
- (6) Pelaksanaan pelayanan PONEK wajib mengacu pada:
- a. Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - b. Panduan Praktik Klinis (PPK);
 - c. Clinical Pathway;
 - d. Program Nasional Keselamatan Pasien;
 - e. Pedoman Penyelenggaraan PONEK yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 11 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

NOMOR : 951.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PONEK

PEDOMAN KERJA TIM PONEK

(PELAYANAN OBSTERI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF) RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Angka Kematian Bayi tercakup Angka Kematian Perinatal, dimana kematian karena gangguan perinatal menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga 1986 adalah 42,3% dari kematian bayi pada usia 0 -1bulan. Mengingat kematian bayi khususnya dalam periode perinatal berkaitan erat dengan kesehatan ibu dimana AKI masih tinggi maka betapa pentingnya pelayanan Maternal dan Perinatal sebagai kegiatan integrative di Rumah Sakit untuk terus ditingkatkan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB.

Penyebab kematian pada masa prenatal/neonatal pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu selama kehamilan, kesehatan janin selama didalam kandungan dan proses pertolongan persalinan yang bermasalah. Komplikasi obstetric tidak selalu dapat diramalkan sebelumnya dan mungkin saja terjadi pada ibu hamil yang diidentifikasi normal. Oleh karena itu perlu strategi penurunan kematian/kesakitan maternal perinatal dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan pembekalan pelatihan secara berkala.

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang harus tersedia selama 24 jam untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan PONEK dilaksanakan secara terpadu oleh tim multidisiplin yang melibatkan tenaga medis, keperawatan, kebidanan, penunjang medis, dan manajemen rumah sakit.

Pedoman Kerja Tim PONEK ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional.

Tim PONEK memiliki tugas utama diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurangi Jumlah Angka Kematian Bayi
2. Mengurangi Jumlah Angka Kematian Ibu

1.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan Pelayanan Maternal dan Perinatal yang bermutu dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan PONEK 24 jam.
2. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan maternal dan neonatal.
4. Memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal.
5. Meningkatkan kompetensi SDM PONEK..
- 6.

1.3 Ruang Lingkup

2. Pelayanan maternal emergensi.
3. Pelayanan neonatal emergensi.
4. Pelayanan kamar operasi emergensi.
5. Pelayanan perinatologi.
6. Pelayanan transfusi darah.
7. Pelayanan laboratorium dan radiologi penunjang.
8. Sistem rujukan maternal dan neonatal.
9. Audit Maternal Perinatal (AMP).

1.4 Sasaran

a. Internal

Direktur, dokter spesialis Obgyn, Anak, anestesi dan umum, Tim PONEK dan tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Prima Husada.

b. Eksternal

Pasien dengan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir.

.

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi PONEK disusun agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan dari penyelenggaraan PONEK. PONEK dibentuk berdasarkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.1 Pimpinan dan Staf

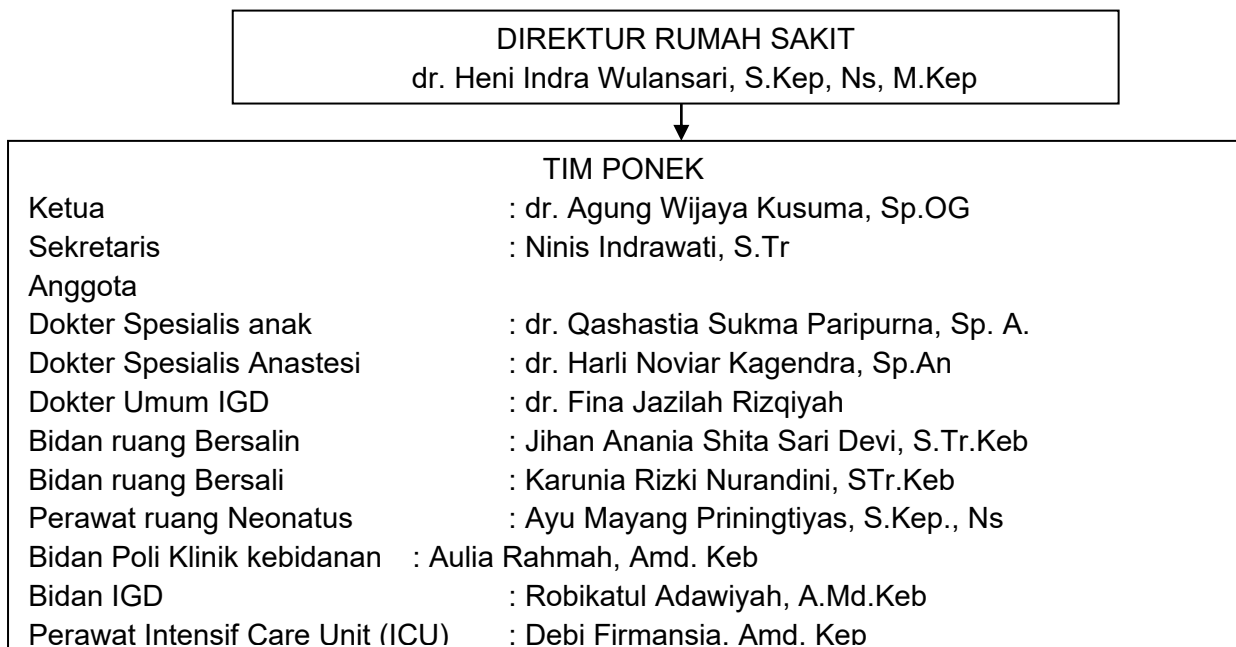
Pimpinan dan petugas kesehatan dalam Tim PONEK diberi kewenangan dalam menjalankan program di rumah sakit.

Kriteria:

1. Tim PONEK minimal disusun terdiri dari :
 - a. 1 dokter Spesialis Kebidanan Kandungan
 - b. 1 dokter spesialis anak
 - c. Dokter Umum IGD
 - d. Bidan ruangan maternitas
 - e. Perawat/Bidan perinatology
 - f. Perawat IGD
 - g. Perawat Anestesi
 - h. Perawat ICU
2. Tim PONEK Ideal ditambah :
 - a. 1 Dokter spesialis anestesi / perawat anestesi
 - b. 6 Bidan pelaksana
 - c. 10 Perawat (tiap shift 2-3 perawat jaga)
 - d. 1 Petugas laboratorium
 - e. 1 pekaya Kesehatan
 - f. 1 Petugas administrasi

Ketua sebaiknya dokter, mempunyai minat, kepedulian dan pengetahuan, pengalaman, mendalami masalah kegawatdaruratan PONEK. Sekretaris sebaiknya bidan, yang disegani, berminat, mampu memimpin, dan aktif.

2.2 Struktur Ponek



2.3 Uraian Tugas dan wewenang

1. Direktur rumah sakit

- a. Membentuk Tim PONEK dengan Surat Keputusan
- b. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan PONEK.
- c. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan
Menentukan kebijakan pelayanan PONEK.
- d. Mengadakan evaluasi kebijakan pelayanan PONEK berdasarkan saran dari Tim PONEK RS
- e. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk pelayanan PONEK RS

2. Tim PONEK

- a. Kriteria Anggota Tim PONEK
 - Mempunyai minat dalam PONEK
 - Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan PONEK
- b. Uraian Tugas
 - a) sebagai motor penggerak penyusunan program PONEK rumah sakit;
 - b) melakukan monitoring dan memandu penerapan program PONEK di unit kerja.
 - c) menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program PONEK.
 - d) terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PONEK.
 - e) bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah PONEK secara rutin kepada ketua PONEK dan direktur Rumah Sakit.
 - f) menyusun regulasi terkait penerapan program PONEK.
- c. Syarat Jabatan
 - a) Pendidikan dasar dokter spesialis kandungan dan kebidanan.
 - b) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya.
 - c) Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi.
 - d) Memiliki kemampuan kepemimpinan.
- d. Wewenang
 - a) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir.
 - b) Memeriksa hasil kegiatan PONEK.
- e. Tanggung jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi PONEK.
 - b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi.
 - c) Bertanggung jawab terhadap Direktur.
- f. Uraian Tugas
 - a) Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - c) Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
- g. Hasil Kerja
Terselenggaranya visi, misi, dan program PONEK di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu.
- h. Sekretaris Tim Ponek
 - a) Syarat Jabatan
 - 1) Pendidikan DIII/Sederajat
 - 2) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang PONEK



- 3) Telah mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidangnya.
- b) Uraian Tugas
 - 1) Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
 - 2) Mengelola administrasi surat-surat PONEK.
 - 3) Mencatat data-data yang berhubungan dengan PONEK.
 - 4) Mencatat data-data yang berhubungan dengan PONEK.
 - 5) Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggungjawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya program PONEK.
 - 6) Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK.
- c) Hasil Kerja
 - 1) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data PONEK.
 - 2) Terkoordinasinya seluruh pelayanan program kegiatan PONEK.
- 3) Anggota Tim Ponek
 - a. IGD
 1. Syarat Jabatan
 - a) Pendidikan DIII/S1 kebidanan/keperawatan
 - b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawat darurat PONEK.
 2. Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan program.
 - b) Bertanggung jawab kepada ketua tim PONEK
 3. Uraian Tugas
 - a) Melaksanakan pelayanan kegawat darurat maternal dan neonatal.
 - b) Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK dan tim medis lain.
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap kasus-kasus kegawat darurat obstetric dan neonatal.
 4. Hasil kerja
Terselenggaranya semua pelayanan kegawat darurat PONEK di Instalasi Gawat Darurat
 - b. Poli Obgyn dan Poli Anak
 1. Syarat Jabatan
 - a) Pendidikan dasar DIII Kebidanan.
 - b) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait obstetric dan ginekologi
 2. Uraian Tugas
 - a) Melaksanakan pelayanan antenatal care (ANC), post natal Care (PNC), program imunisasi, program keluarga berencana, pelaksanaan tumbuh kembang bayi, balita dan anak..
 - b) Pemantauan pelaporan pelayanan PONEK.
 - c) Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK terkait dengan pelayanan PONEK.
 3. Hasil Kerja
Terselenggaranya semua pelayanan PONEK di Poli Obgyn dan Poli Anak
 - c. Ruang Bersalin & Nifas
 1. Syarat Jabatan
 - a) DIII Kebidanan dan DIV Kebidanan
 - b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang PONEK
 - c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan
 2. Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK
 - b) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya.
 3. Uraian Tugas
 - a) Membuat perencanaan untuk pelayanan di ruang bersalin dan pelayanan nifas

- b) Melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelayanan persalinan dan nifas (pengawasan dan perawatan nifas, IMD, menyusui, perawatan payudara, rawatgabung, PMK pada bayi berat badan rendah, Pemberian ASI Eksklusif).
 - c) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan tim pelayanan perinatal dalam rangka kegiatan operasional
 - d) Melakukan pengawasan kegiatan di ruang bersalin dan ruang nifas.
 - e) Melakukan pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - f) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan PONEK termasuk pencatatan dan pelaporan.
4. Hasil kerja
Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di ruang bersalin
- d. Pelayanan Perinatologi
- 1. Syarat Jabatan
 - a) DIII Kebidanan atau Keperawatan.
 - b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
 - c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan NICU/PICU/ Kegawatdaruratan Neonatal
 - 2. Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di ruang perinatologi.
 - b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.
 - 3. Uraian Tugas
 - a) Membuat perencanaan untuk pelayanan perinatologi.
 - b) Mengawasi dan melakukan kegiatan-kegiatan PONEK di ruang perinatologi seperti Pelayanan Metode Kangguru Pada Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah, IMD di ruang bersalin dan ruang recovery room (RR), Rawat Gabung Ibu dan bayi, Pemberian ASI Eksklusif.
 - c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional.
 - d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan perinatologi termasuk pencatatan dan pelaporan
 - 4. Hasil Kerja
Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di ruang perinatologi.
- e. Pelayanan ICU
- 1. Syarat Jabatan
 - a) S1 Keperawatan.
 - b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
 - c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kegawatan atau ICU
 - 2. Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya
 - b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.
 - 3. Uraian Tugas
 - a) Membuat perencanaan untuk pelayanan pasien di ICU.
 - b) Mengawasi kegiatan-kegiatan PONEK di ruang ICU.
 - c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional.
 - d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan PONEK di ICU termasuk pencatatan dan pelaporan



4. Hasil Kerja
Terselenggaranya semua pelayanan PONEK di ruang ICU.
- f. Pelayanan Kamar Operasi
 1. Syarat Jabatan
 - a) S1 Keperawatan.
 - b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
 - c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penanganan kegawatdaruratan PONEK
 2. Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan program PONEK di instalasi IKO
 - b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.
 3. Uraian Tugas
 - a) Membuat perencanaan untuk pelayanan pasien kegawatdaruratan obstetric neonatal di ruang kamar Operasi
 - b) Mengawasi kegiatan-kegiatan pelayanan di ruang kamar Operasi terkait pelayanan PONEK.
 - c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional, seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang dilakukan di kamar operasi.
 - d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan ginekologi di ruang operasi termasuk pencatatan dan pelaporan
 4. Hasil Kerja
Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di instalasi kamar operasi.
- 2.4 Sarana dan fasilitas pelayanan penunjang (*Supporting System*)
 1. Sarana Kesekretariatan
 - a. Tersedianya ruangan meeting
 - b. Komputer, printer, dan internet.
 - c. Telepon
 - d. Alat tulis kantor.
 2. Dukungan Manajemen
Dukungan yang diberikan oleh manajemen berupa:
 - a. Penerbitan Surat Keputusan untuk Tim PONEK RS
 - b. Anggaran atau dana untuk kegiatan :
 - 1) Pendidikan atau Pelatihan (diklat)
 - 2) Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
 - 3) Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
 - 4) Intensif/Tunjangan/Reward untuk Tim PONEK RS
 3. Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional
Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit adalah:
 - a. Kebijakan Manajemen
 - 1) Adanya kebijakan tentang pengembangan SDM dalam PONEK.
 - 2) Adanya kebijakan tentang pengadaan bahan dan alat yang melibatkan tim PONEK.
 - 3) Adanya kebijakan tentang pemeliharaan fisik dan sarana yang melibatkan tim PONEK.
 4. Pengembangan dan Pendidikan
 - a. Wajib memiliki pendidikan dan pelatihan PONEK

- b. Memiliki sertifikat PONEK
- c. Mengembangkan diri mengikuti seminar, lokakarya, dan sejenisnya.
- d. Bimbingan teknis secara berkesinambungan.

BAB III

PROGRAM PONEK

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam, Tim PONEK Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan Menerapkan Standar Pelayanan Perlindungan Ibu dan Bayi Secara Terpadu
 - a. Tujuan:
Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang aman, bermutu, efektif, dan berkesinambungan.
 - b. Kegiatan:
 - 1)Menerapkan standar pelayanan maternal dan neonatal sesuai pedoman nasional.
 - 2)Melaksanakan pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan neonatal secara terpadu.
 - 3)Menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam.
 - 4)Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan ibu dan bayi.
 - 5)Melakukan koordinasi lintas profesi dalam penanganan kasus maternal dan neonatal.
 - c. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Tersedianya standar operasional prosedur (SPO) pelayanan ibu dan bayi.
 - 2) Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan $\geq 90\%$.
 - 3) Pelayanan PONEK tersedia 24 jam setiap hari.
 - 4)
2. Mengembangkan Kebijakan dan Standar Pelayanan Ibu dan Bayi
 - a. Tujuan:
Mewujudkan keseragaman dan peningkatan mutu pelayanan ibu dan bayi
 - b. Kegiatan:
 - 1) Menyusun dan memperbarui kebijakan pelayanan maternal dan neonatal.
 - 2) Menyusun pedoman, panduan praktik klinis, dan SPO terkait pelayanan PONEK.
 - 3) Melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh tenaga kesehatan.
 - 4) Melaksanakan evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala.
 - c. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Seluruh kebijakan dan SPO terdokumentasi dan disahkan.
 - 2) Kebijakan dievaluasi minimal 1 kali dalam setahun.
 - 3) Seluruh staf terkait memahami kebijakan yang berlaku
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
 - a. Tujuan:
Meningkatkan mutu pelayanan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
 - 2) Melakukan audit medis dan audit maternal perinatal.
 - 3) Melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

- 4) Mengembangkan indikator mutu pelayanan maternal dan neonatal.
- 5) Melakukan survei kepuasan pasien.
- c. Indikator Keberhasilan:
 - a. Terlaksananya program peningkatan mutu secara berkala.
 - b. Meningkatnya capaian indikator mutu pelayanan.
 - c. Menurunnya kejadian yang tidak diharapkan pada pelayanan ibu dan bayi.
4. Meningkatkan Kesiapan Rumah Sakit dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Obstetri dan Neonatus Termasuk Pelayanan Kegawatdaruratan (PONEK 24 Jam)
 - a. Tujuan:

Menjamin kesiapan sumber daya rumah sakit dalam memberikan pelayanan PONEK selama 24 jam.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Menyediakan tenaga kesehatan kompeten sesuai standar PONEK.
 - c. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana, obat-obatan, dan alat kesehatan.
 - 1) Menyelenggarakan sistem on-site dan on-call sesuai kebutuhan pelayanan.
 - 2) Melakukan simulasi penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
 - 3) Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala.
 - d. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Pelayanan PONEK tersedia 24 jam.
 - 2) Ketersediaan SDM, alat, dan obat sesuai standar.
 - 3) Respon kegawatdaruratan sesuai target waktu yang ditetapkan.
5. Meningkatkan Fungsi Rumah Sakit sebagai Model dan Pembina Teknis dalam Pelaksanaan IMD, ASI Eksklusif, serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR
 - a. Tujuan:

Mendukung peningkatan status kesehatan bayi baru lahir melalui penerapan praktik terbaik.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada setiap persalinan yang memenuhi syarat.
 - 2) Mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif.
 - 3) Melaksanakan Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada bayi berat lahir rendah (BBLR).
 - 4) Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga.
 - 5) Melakukan pembinaan kepada fasilitas kesehatan jejaring.
 - c. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Meningkatnya cakupan IMD.
 - 2) Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif.
 - 3) Seluruh BBLR yang memenuhi kriteria mendapatkan PMK.
6. Meningkatkan Fungsi Rumah Sakit sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi bagi Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - a. Tujuan:

Meningkatkan efektivitas sistem rujukan maternal dan neonatal.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan rujukan maternal dan neonatal selama 24 jam.
 - 2) Mengembangkan jejaring rujukan dengan fasilitas kesehatan pengirim.
 - 3) Melaksanakan komunikasi, informasi, dan koordinasi rujukan.
 - 4) Memberikan umpan balik terhadap kasus rujukan.
 - 5) Melaksanakan pembinaan teknis kepada fasilitas kesehatan jejaring.

- c. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Terjalannya jejaring rujukan yang efektif.
 - 2) Tersedianya mekanisme rujukan dan rujuk balik.
 - 3) Meningkatnya kualitas koordinasi antar fasilitas kesehatan.
7. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program RSSIB, 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, dan Peningkatan Kesehatan Ibu
 - a. Tujuan:

Menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Melakukan monitoring pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB).
 - 2) Melakukan evaluasi penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.
 - 3) Mengumpulkan dan menganalisis data capaian program.
 - 4) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.
 - 5) Menetapkan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
 - c. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.
 - 2) Tersusunnya laporan hasil evaluasi.
 - 3) Terlaksananya tindak lanjut perbaikan program.
8. Melakukan Pemantauan dan Analisis Indikator Pelayanan PONEK sebagai berikut :
 - a. Operasi Seksio Sesarea (SC)
 - 1) Kegiatan:
 - a) Mengumpulkan data waktu keputusan operasi sampai tindakan operasi dilakukan.
 - b) Menghitung angka keterlambatan operasi SC.
 - c) Menganalisis faktor penyebab keterlambatan.
 - d) Menyusun rekomendasi perbaikan.
 - 2) Indikator Keberhasilan:
 - a) Menurunnya angka keterlambatan operasi SC.
 - b) Waktu tanggap operasi SC emergensi sesuai standar yang berlaku.
 - b. Angka Kematian Ibu dan Anak
 - 1) Kegiatan:
 - a) Mengumpulkan data kematian ibu dan bayi.
 - b) Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP).
 - c) Mengidentifikasi faktor penyebab kematian.
 - d) Menetapkan tindakan korektif dan pencegahan.
 - 2) Indikator Keberhasilan:
 - a) Terselenggaranya audit pada setiap kasus kematian.
 - b) Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.
 - c. Kejadian Tidak Dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir
 - 1) Kegiatan:
 - a) Melakukan pencatatan pelaksanaan IMD.
 - b) Mengidentifikasi penyebab tidak terlaksananya IMD.
 - c) Melakukan edukasi kepada tenaga kesehatan dan keluarga pasien
 - d) Melaksanakan tindak lanjut perbaikan.
 - 2) Indikator Keberhasilan:
 - a) Meningkatnya cakupan IMD.
 - b) Menurunnya angka bayi baru lahir yang tidak mendapatkan IMD tanpa indikasi medis yang jelas.

BAB IV

MONEV DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring Program

Monitoring Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, standar pelayanan, serta kebijakan rumah sakit yang telah ditetapkan.

1. Tujuan Monitoring

- a. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan pelayanan PONEK berjalan sesuai standar pelayanan, pedoman, dan prosedur operasional yang berlaku.
- c. Mengidentifikasi hambatan, kendala, dan permasalahan dalam pelaksanaan program.
- d. Menilai efektivitas penggunaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan.
- e. Menyediakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan mutu pelayanan.

2. Ruang Lingkup Monitoring

Monitoring dilakukan terhadap :

- a. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia PONEK.
- b. Ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat-obatan.
- c. Pelaksanaan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi 24 jam.
- d. Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, dan Perawatan Metode Kanguru (PMK).
- e. Pelaksanaan sistem rujukan maternal dan neonatal.
- f. Penerapan standar keselamatan pasien.
- g. Capaian indikator mutu pelayanan PONEK.
- h. Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB).

3. Metode Monitoring

Monitoring dilakukan melalui:

- a. Pengumpulan dan verifikasi data pelayanan.
- b. Telaah rekam medis.
- c. Supervisi lapangan.
- d. Audit kasus maternal dan neonatal.
- e. Audit Maternal Perinatal (AMP).
- f. Observasi penerapan standar pelayanan.
- g. Rapat koordinasi dan evaluasi Tim PONEK.

4. Waktu Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilaksanakan secara:

- a. Harian untuk pelayanan kegawatdaruratan.
- b. Bulanan untuk indikator pelayanan dan mutu.
- c. Triwulanan untuk evaluasi program.
- d. Tahunan untuk evaluasi menyeluruh program PONEK.

4.2 Evaluasi Program PONEK

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program serta mengukur pencapaian sasaran dan indikator yang telah ditetapkan

1. Tujuan Evaluasi

- a. Menilai efektivitas pelaksanaan program PONEK
 - b. Menilai pencapaian indikator kinerja dan mutu pelayanan
 - c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.
 - d. Menetapkan rekomendasi tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan.
2. Aspek yang Dievaluasi
- Evaluasi dilakukan terhadap:
- a. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi
 - 1) Ketersediaan pelayanan 24 jam.
 - 2) Kesiapan tim PONEK.
 - 3) Kecepatan respon pelayanan kegawatdaruratan.
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
 - 1) Pelaksanaan standar pelayanan maternal dan neonatal.
 - 2) Pelaksanaan IMD.
 - 3) Pelaksanaan ASI Eksklusif.
 - 4) Pelaksanaan PMK pada BBLR.
 - c. Sistem Rujukan
 - 1) Ketepatan proses rujukan.
 - 2) Efektivitas komunikasi rujukan dan rujuk balik.
 - 3) Respon terhadap kasus rujukan emergensi.
3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
- Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Penyusunan rencana perbaikan mutu pelayanan.
 - b. Revisi kebijakan, pedoman, dan prosedur operasional.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana.
 - e. Penyusunan program kerja tahun berikutnya.

4.3 Pelaporan Program PONEK

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi kepada pimpinan rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan pengambilan keputusan.

1. Tujuan Pelaporan
 - a. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan program PONEK.
 - b. Mengetahui perkembangan dan capaian indikator program.
 - c. Menjadi dasar perencanaan dan pengembangan program.
 - d. Memenuhi kebutuhan pelaporan internal dan eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jenis Pelaporan
 - a. Laporan Bulanan
Memuat :
 - 1) Jumlah kunjungan maternal dan neonatal.
 - 2) Jumlah persalinan.
 - 3) Jumlah tindakan seksio sesarea.
 - 4) Jumlah kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.
 - 5) Jumlah rujukan masuk dan keluar.
 - 6) Capaian indikator mutu PONEK.
 - 7) Permasalahan dan tindak lanjut.
 - b. Laporan Triwulanan
Memuat :
 - 1) Rekapitulasi capaian program.
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi.
 - 3) Analisis indikator mutu.
 - 4) Hasil audit kasus.
 - c. Laporan Tahunan

Memuat:

- 1) Evaluasi pelaksanaan program selama satu tahun.
- 2) Capaian target program.
- 3) Analisis tren indikator pelayanan.
- 4) Hasil Audit Maternal Perinatal.
- 5) Rekomendasi pengembangan program.
- 6) Rencana kerja tahun berikutnya.

3. Mekanisme Pelaporan

- a. Data dikumpulkan oleh anggota Tim PONEK dari unit pelayanan terkait.
- b. Data diverifikasi oleh koordinator atau sekretaris Tim PONEK.
- c. Data dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan berkala.
- d. Laporan disampaikan kepada Ketua Tim PONEK.
- e. Ketua Tim PONEK melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Direktur Rumah Sakit.
- f. Hasil laporan digunakan sebagai bahan rapat manajemen, peningkatan mutu, dan penyusunan kebijakan pelayanan.

4. Dokumentasi Pelaporan

Seluruh dokumen monitoring, evaluasi, audit, dan laporan program PONEK wajib didokumentasikan, disimpan, dan dipelihara sesuai ketentuan pengelolaan dokumen rumah sakit guna menjamin ketersediaan data untuk kebutuhan evaluasi, akreditasi, dan pengembangan pelayanan di masa mendatang.

BAB V TATALAKSANA

Kegiatan Tim PONEK di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif harus dilaksanakan oleh Tim PONEK rumah sakit dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dari kejadian tindakan yang telah dilakukan kepada pasien, yang berbasis patient safety.

5.1 Pelayanan Rawat Jalan

Tata Laksana pelayanan perinatal resiko tinggi dalam ruang lingkup pelayanan rawat jalan terkait dengan kegiatan terprogram dari instalasi rawat jalan yaitu dalam pelayanan di Poli Kebidanan dan Kandungan. Poliklinik Anak yang terjadwal setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00. Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan adalah :

1. Poliklinik Anak
 - a. Imunisasi Layanan imunisasi di poliklinik anak meliputi program imunisasi Wajib dan imunisasi yang dianjurkan. Pelaksanaan imunisasi dilakukan setiap hari kecuali imunisasi BCG dan MR setiap hari sabtu jam 07.00 sampai dengan selesai .Selain imunisasi wajib, poliklinik anak juga melayani imunisasi lain seperti: Infarix Hexa/Hexaxim, prevenar, Rotarix, Rotatex, Typhim, Vaxigrip,MMR
 - b. Pemeriksaan rutin bayi baru lahir dan perawatan tali pusat Pemeriksaan rutin bayi baru lahir dilakukan setiap hari oleh dokter spesialis anak meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan kondisi umum dan fisik, pemantauan pemberian ASI dan kemampuan minum bayi. Pada saat perawatan tali pusat, dilakukan juga pemeriksaan tanda-tanda adanya infeksi tali pusat, serta edukasi mengenai cara perawatan tali pusat yang benar kepada orang tua. Dalam pemantauan pada bayi kurang bulan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan dan perkembangan apakah sudah dapat tumbuh kejar pada kronologis pertumbuhannya, komplikasi atau gangguan perkembangan yang mungkin terjadi.
2. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan.
 - a. Pelayanan pasien di poliklinik kebidanan dan kandungan dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan setiap hari kerja 08.00 sampai dengan selesai meliputi :
 - 1) Perawatan masa hamil yang meliputi kondisi kandungan.Pada kasus tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium dan USG.
 - 2) Perawatan masa nifas bagi ibu post partum, meliputi pencatatan keluhan, pemeriksaan fisik, perawatan luka episiotomi atau luka post operasi.
 - 3) Dalam pelayanan pasien di poliklinik ini dilakukan juga deteksi dini kehamilan yang mempunyai resiko tinggi serta penatalaksanaannya bahkan pencegahan komplikasi lebih lanjut dengan intervensi pengobatan yang diperlukan, dilakukan pencatatan serta perencanaan dalam proses persalinan untuk resiko tinggi
 - b. Pelayanan KB.
 - 1) Sasaran: setiap pasangan suami istri usia produktif yang bertujuan untuk mengatur kehamilan.
 - 2) Jenis pelayanan kontrasepsi : IUD, pil KB, implan atau susuk, suntik,

kondom, MOW

c. Kandungan.

Pelayanan pemeriksaan wanita dengan gangguan ginekologis, misalnya mioma, kista uteri, endometriosis

5.2 Pelayanan Rawat Inap.

Pelayanan rawat inap terkait secara fungsional dengan instalasi rawat inap dengan pintu masuk baik dari poliklinik maupun rawat darurat dengan kasus-kasus kehamilan patologis yang persalinan yang direncanakan maupun kasus-kasus rujukan dengan kondisi gawat darurat. Pelayanan rawat inap ada pada lantai 4C Rumah Sakit Prima Husada dengan kapasitas 13 tempat tidur, dan 6 bed tindakan, untuk neonatus yang lahir di Rumah Sakit Prima Husada terdapat 13 box bayi, 3 inkubator, 4 cuvis, 4 C-pap Mesin. Untuk neonatus kasus rujukan atau lahir di luar Rumah Sakit Prima Husada di rawat di ruang neonatus rujukan luar dengan kapasitas 2 box, 1 inkubator.

5.3 Klasifikasi Penyakit

Berbagai klasifikasi kasus yang dapat menjadi bagian dalam pelayanan perinatal resiko tinggi adalah

1. Kehamilan normal
2. Pelayanan Kesehatan Maternal dengan masalah yaitu:
3. Syok
4. Perdarahan pada kehamilan muda
5. Perdarahan pada kehamilan lanjut dan persalinan
6. Perdarahan pasca persalinan
7. Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan atau koma
8. Tekanan darah tinggi
9. Persalinan lama
10. Malpresentasi dan malposisi
11. demam dalam kehamilan dan persalinan
12. demam pasca persalinan
13. nyeri perut pada kehamilan muda, pada kehamilan lanjut dan persalinan
14. gerak janin tidak dirasakan
15. ketuban pecah dini
16. gawat janin dalam persalinan

Kasus yang terkait dengan kesehatan neonatus:

1. Neonatus normal
2. Neonatus bermasalah :
 - a. asfiksia neonatorum
 - b. tetanus neonatorum
 - c. sepsis
 - d. traumalahir
 - e. sindroma gangguan pernapasan
 - f. bayi berat lahir rendah
 - g. kelainan kongenital
 - h. ikterus neonatorum
3. bayi lahir dengan ibu bermasalah : infeksi hepatitis B, diabetes melitus dan ibu dengan TBC

5.4 Penyelesaian dan pengembalian Rekam Medis

Data Rekam Medis yang berkaitan dengan pelayanan perinatal resiko tinggi disesuaikan dengan segala persyaratan dan ketentuan dari instalasi rekam medis baik dalam hal pengisian, waktu penyelesaian kelengkapan serta pengembalian

data. Pengisian rekam medis sesuai dengan ketentuan rekam medis dan pengembalian rekam medis 1 x 24 jam.

5.5 Sistem Rujukan.

1. Pengertian Rujukan

Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:

a. Rujukan Pasien

- Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit.
- Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada

b. Rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (dana, alat dan sarana).

c. Rujukan Manajemen

Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.

2. Sistem pelayanan rujukan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada

Bila pasien maternal dan perinatal tidak dapat ditangani sendiri segera rujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap fasilitas dan tenaga kesehatannya. Harus ada koordinasi, mudah sehingga tidak merugikan pasien. Mudah, cepat dan tepat adalah yang utama. Rujukan internal rumah sakit berpedoman kepada prosedur rujukan di dalam rumah sakit dan mekanisme kerja di bagian /instalasi Anak, Obstetri, dan Ginekologi. Rujukan eksternal mengikuti mekanisme rujukan sesuai jenjang pelayanan. Persiapan Rujukan Pasien ke jenjang pelayanan yang lebih tinggi:

- a. Menyiapkan petugas yang terlatih untuk mendampingi pasien
- b. Memberi penjelasan kepada pihak keluarga alasan pasien di rujuk ke rumah sakit lain.
- c. Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
- d. bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- e. Pada saat merujuk pasien harus disertakan surat rujukan dan resume medik pasien meliputi: riwayat penyakit, penilaian kondisi pasien yang dibuat saat kasus diterima perujuk, tindakan atau pengobatan yang telah diberikan dan keterangan lain yang perlu atau ditemukan sehubungan dengan kondisi pasien. Proses pelaksanaan rujukan harus mendapat persetujuan dari dokter dan keluarga
- f. Rumah Sakit sebagai penerima rujukan:
Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- g. Persiapan pihak keluarga untuk memberikan darah jika dibutuhkan
Pasien/keluarga diberi penjelasan mengenai tindakan/perawatan yang akan dilaksanakan.

BAB VI PENUTUP

Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan unsur pelaksana di rumah sakit yang berperan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan selama 24 (dua puluh empat) jam. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PONEK sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kompetensi, serta kerja sama seluruh anggota tim dan unit terkait dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku.

Pedoman Kerja Tim PONEK ini disusun sebagai acuan bagi seluruh anggota Tim PONEK dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangannya guna mewujudkan pelayanan maternal dan neonatal yang aman, efektif, efisien, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh kegiatan pelayanan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga mampu mendukung upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi di rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 12 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Henri Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep